<2022 본 3 학년말고사- 내과>

총 **60 문제** 중 **OO 문제** 복원

대략적인 경향성도 적어주세요

대거 탈야마. 혈종은 학년말, 계통 야마 조금 탔음.

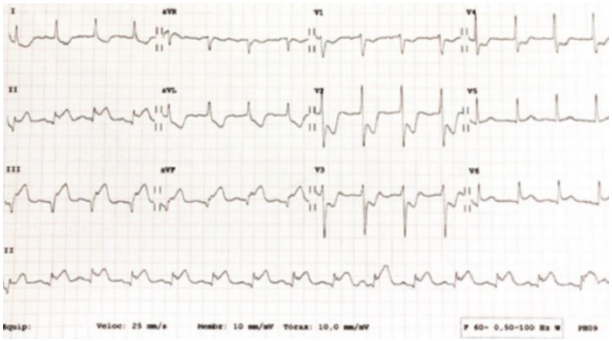
심장, 호흡이 상대적으로 쉬운 편이었고 나머지 어려웠음.

<심장내과>

총 **10 문제** 중 **10 문제** 복원

1. 44 세 남성이 1 시간 전부터 점점 심해지는 흉통으로 내원하였다. 5 년 전부터 고혈압약 복용중이었다. BP 90/50 HR 120 정도이며 CK-MB 1800, Troponin 200 정도로 상승되었다. 우선적으로 해야 할 처치는 무엇인가?

   (EKG: II, III, avF elevation)



   - 응급관상동맥중재술
   - NS 없었음.

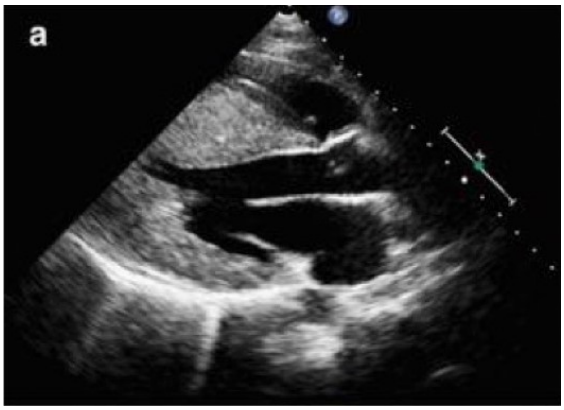
2. 60 세 남성이 흉통과 가슴답답함으로 내원하였다. V/S 는 정상이었다.

   (EKG: V3,4,5,6 elevation EKG)



   - 응급 PCI
   - NS 없었음.

3. 20 세 남자가 수영하다가 가슴 통증을 느껴 내원하였다. 내원 이후의 V/S 은 안정적이었다. 환자의 아버지가 45 세에 급사한 가족력 있었다. 처치는?



   - ICD
   - 경피적 대동맥판 삽입술
   - 경피적 승모판 재건술

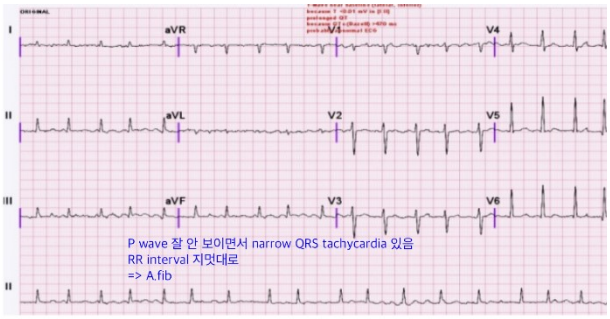
4. 54 세 여자가 하루전부터 숨이 차서 응급실에 내원하였다. 1 년전부터 유방암 치료받음. BP 70/40mmHg, HR 110/min, RR 22/min 체온 36.4 이다. 가슴 청진에서 심음이 작게 들리고 호흡음은 정상이다. 경정맥의 높이가 복장각에서 8cm 높이에서 측정됨. 심초음파 결과는 다음과 같다. 치료는?

   (*당해 임종평 4 차 한양대 Y)




- 응급 심낭천자
- 가슴관 삽입
- 이뇨제 사용
- 글루코코르티코이드
- 경과관찰

5. 55 세 남자가 2 주 전 과음 후 1 시간 정도 두근거림이 있었던 후 호전되었다. 1 주 전부터는 음주하지 않아도 두근거렸다. 평소 고혈압으로 ACEi 복용중이었다. BP 135, HR 127. 치료는? (EKG: Afib)



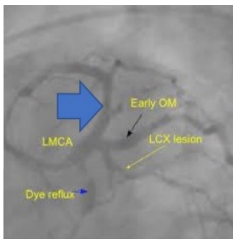
- BB 추가 (답)
- Amiodarone
- 심율동 전환
- 이뇨제 추가
- 고주파 도자 절제술

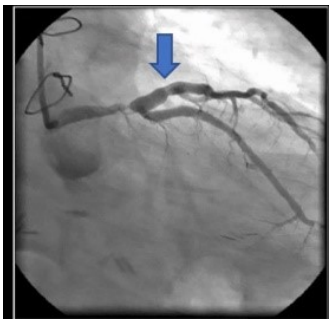
6. 숨찬 증상과 심부전 있는 환자가 내원하였다. EF 37 로 측정된 HFrEF 환자로, 다음 중 생존율을 개선할 수 있는 치료는?



- Spironolactone
- thiazide
- furosemide
- aspirin
- amiodarone

7. 다음 혈관조영술에서 가리키는 혈관은 무엇인가? (LAD proximal stenosis, LCx distal stenosis 있었음. 21 야마에 비슷한 사진 있어서 가져옴)



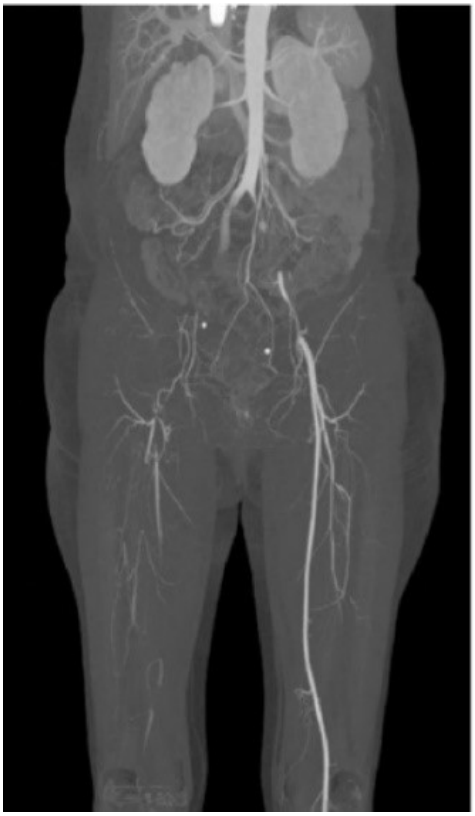


- LCX
- LAD (답)
- RCA
- Left. main

8. 55 세 남자가 몇 년 전부터 오른쪽 다리에 간헐적인 통증이 있었으며 걸으면 나아지는 양상이었다. 몇 달 전부터는 왼쪽 다리도 간

헐적인 통증이 있었으며 나아지지 않았다. (ABI: 좌 0.7 우 0.5~0.6) Angiography 소견은 다음과 같았다.(좌측 혈관 막힘) 치료는?

(혈전용해제 보기에 없었음)



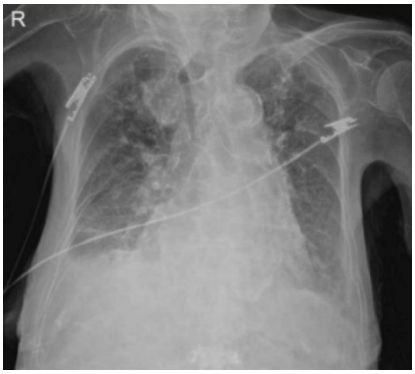
- 경피적혈관성형술

9. 54 세 남자, 흉통으로 심첨부를 벨로 들은 심음이 다음과 같다.

   [이어폰 가져올 것을 미리 공지하지 않아서 전원정답처리]

   - S4
   - S3
   - Click
   - Opening snap
   - Ejection sound

10. 88 세 여자가 5 일전부터 발생한 호흡곤란으로 응급실에 왔다. 고혈압과 부정맥의 과거력이 있다. 혈압 110/78mmHg, 맥박수 84/min, 체온 36.5, 호흡 28/min 이다. 증상 호전을 위한 약물은?





- 경구 이뇨제
- 경정맥 이뇨제
- 광범위 항생제
- 경구 항응고제
- 경구 스테로이드

<호흡기내과>

총 **10 문제** 중 **10 문제** 복원

작년 학기말고사와 당해 호흡기내과 계통강의 기출에서 많이 나왔습니다.

11. (Spirometry 검사결과 줌. FVC, FEV1, FEV1/FVC 모두 정상보다 낮은 상태) 중증도를 평가하기 위해 가장 필요한 검사는?

    - Chest X-ray
    - 호흡곤란정도 설문지
    - DLCO

- 6 분 걷기 검사
- Holter monitoring

12. (내신야마) 다음 검사방법 중 폐암의 병기를 판정하는데 사용되는 검사가 아닌 것은?
    - Brain MRI
    - PET-CT
    - 복부 CT
    - Whole body bone scan
    - 폐기능검사

13. 천식으로 ICS 사용 중인 환자이다. 최근 일주일에 2 번 이상 낮에 증상이 심해지고 밤에 자다가 깨기도 하며, 일상 생활에 지장이 많다. 흡입제는 매일 1 회 사용 중이다. 환자에게 필요한 치료는?
    - 저용량 흡입스테로이드
    - 저용량 흡입스테로이드와 지속성 베타 2 효현제
    - 경구 스테로이드
    - 테오필린
    - 속효성 베타 2 효현제

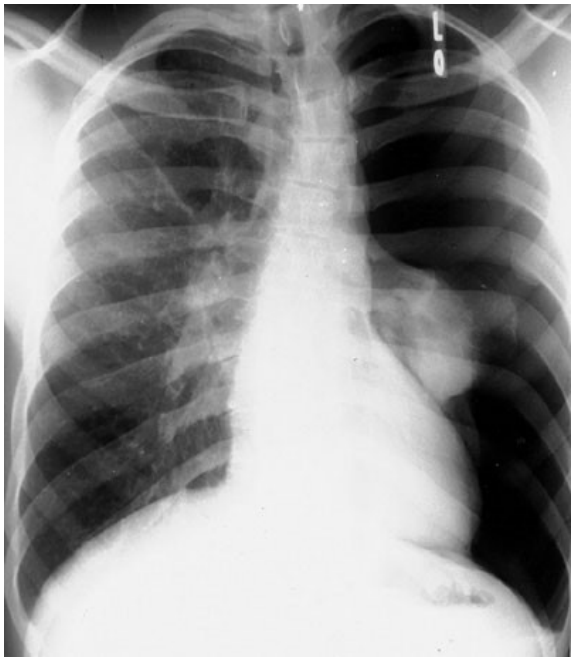
(모든 선지 한글로 나왔으며, 선지에 LAMA 없었음)

14. 비결핵성항산균(NTM) 감염으로 치료를 받던 중에 갑자기 눈이 잘 보이지 않는다고 하였다. 원인이 될 약물로 가장 가능성이 높은 것은?
    - Isoniazid
    - Ethambutol
    - Moxifloxacin
    - Rifampin
    - Pyrazinamide

15. 54 세 남성이 3 년전 M.abscessus 진단되고 3 개월간 결핵 초기 치료(4 제요법)하다가 증상이 호전되어 자의 중단하였다. 2 년전 해외 출장에서 돌아오고 3 개월 후부터 다시 증상이 생겨 내원하였다. AFB 검사와 PCR 둘다 양성. 앞으로 해야할 것은?
    - Xpert MTB/RIF 검사를 한다.
    - 초치료 실패에 해당한다.
    - Paradoxical response 일 수 있으니 현재 치료를 유지한다.
    - 폐외결핵 증상이 있는지 확인한다.
    - 2 차 치료 약제로 변경한다.

16. (야마) 다음 질환의 정확한 진단을 위해 시행해야 할 검사는? (PA view 와 Decubitus X-ray 제시해줬는데 PA 에서 CPA blunting 이 있었고 decubitus 에서 fluid 가 움직임이 있었음.)
    - 흉수검사 - 흉부 CT
    - 혈액검사 - 흉부 CT
    - 혈액검사 - 흉수검사
    - 흉수검사 - 흉부 MRI
    - 흉부 CT - 흉부 MRI

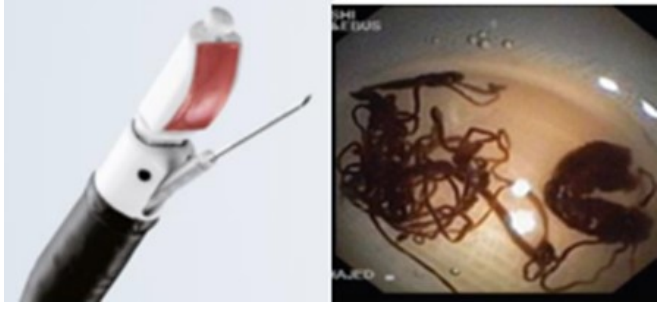
17. (좌폐에 pneumothorax 있는 흉부 X-ray 사진 주어짐, 사이즈 매우 컸음 - 유사한 사진 구글링)



좌폐에 종괴 발견되어 세침흡인검사 시행하였으나 이후 숨차다고 하여 X-ray 찍어본 결과 다음과 같음. 처치는?

- 혈관조영술
- 흉막유착술
- 흉강천자

18. (야마) 60 대 남성이 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 다음은 CT, PET-CT 검사 결과이다. (carina 주변에서 hypermetabolic 한 LN 3 군데 보임) 그리고 시행한 검사에서 사용한 기구와 채취한 검체의 육안적 소견 사진을 보았을 때, 이 검사의 이름은?



- Autofluorescence Bronchoscopy(AFB)
- Electromagnetic Navigational Bronchoscopy (ENB)
- Endobronchial Ultrasound-Guided Transbronchial Needle Aspiration (EBUS-TBNA)
- Transbronchial Lung Biopsy (TBLB)

19. 스테로이드 흡입제와 경구 스테로이드 비교로 옳은 것은?

- 흡입 스테로이드는 소량으로도 경구 제제와 동일한 효과를 얻을 수 있고 전신 부작용이 더 적은 장점이 있다.
- 천식환자에서 스테로이드 치료는 경구로 투여하는 것이 적절하다.

20. (ARDS 의 X-ray 줌(아마 AP). 여러 인공물들이 폐야와 혈관들에 보였음.) 중환자실에서 조치를 취하고 있다. 다음 중 부적절하게 삽입된 것은?

- Central line
- Arterial line
- Endotracheal tube
- Nasogastric tube
- Urinary Catheter

(답논란. 가슴 사진이라 선지의 urinary catheter 는 생각할 필요도 없었습니다.)

<소화기내과>

총 **10 문제** 중 **10 문제** 복원

21. (Y) 수면내시경 도중 산소포화도가 75%로 떨어졌다. 산소를 공급했으나 변화가 없다. 취할 조치로 옳은 것은?

- 수면제에 대한 길항제를 투여한다.
- 산소 농도를 올린다.
- 일단 경과를 보면서 그대로 검사를 진행한다.
- 심전도 검사를 시행한다.
- 기관 삽관을 시행한다.

22. 25 세 남성이 10 회 이상의 설사로 내원하였다. 구불결장직장 내시경에서 궤양, 발적 산재되어 있다. Crypt abscess, cryptitis. 치료는?(선지 모두 한글로 나옴)

- 스테로이드
- 살리실산
- N/S
- 5-ASA

23. 혈변으로 내원한 환자. 평소 허리통증으로 NSAIDs 복용중이다. BP 80/50 HR 120. 가장 우선적으로 해야 할 처치는?

- 내시경적 지혈
- 생리식염수 정주
- IV 고용량 PPI
- 항생제

24. 91 세 여성이 2 주 전부터 복통이 있었으며 3 일 전부터 변이 나오지 않았다.

BT 38.1

WBC 18000 CRP 12

X-ray, CT (axial, obstruction & bowel wall enhancement...?)

가장 적절한 처치는?

- Rectal tube 로 감압한 후 관찰
- 장정결제 복용 후 관찰
- 장폐색으로 허혈성 장염 및 패혈증이 의심되므로 수술
- Nasogastric tube 넣고 감압

25. 60 세 남성이 붉은 피를 토해 내원하였다. 평소 하루에 소주 한 병을 마시던 환자였다.

BP-80/46, HR-122, RR-18, BT- 37.1

Hb-8.2, INR-1.8, GGT-1,110

(이외 lab 이상소견 없었음)

먼저 시행해야할 처치는?

- Terlipressin
- 내시경적 지혈술
- 예방적 항생제
- 수혈
- 정맥 식염수 투여

26. 58 세 여자 환자가 초음파에서 간 결절이 보여 내원하였다. HBV 보유자로 과거 B 형 간염을 진단받았으나 치료받지 않았다. 최근 시행한 복부 CT 검사에서 간 좌엽에 7.5cm 크기의 동맥기 조영증강, 정맥기/문맥기 조영감소되는 병변이 관찰되었다. 영상검사에서 기타 이상소견은 관찰되지 않았다.
혈액검사
Hb 12.8 WBC 8,000 PLT 175,000
AST/ALT 29/36
Total bilirubin 1.3mg/dL, albumin 3.8mg/dL, PT(INR) 1.13, prothrombin time 82%
AFP 546ng/mL
(복수, 간성뇌증 소견 제시되지 않음.)

환자의 장기적인 생존율을 위한 가장 좋은 치료는?

- TACE
- RFA
- 간 절제술
- 간 이식술
- stereotactic body radiation therapy(정위적 체부 방사선 요법)

27. 46 세 남성. 8 일 전 고열과 우상복부 통증이 있어 병원에 내원하였고 담낭 절제술과 경피 배액술을 받았다. 수술 후 배액줄에서 250ml 의 갈색 담즙이 계속 나왔으며 우상복부 복통과 반발압통이 지속되어 ERCP 를 시행하였고 조영제가 수술부위에서 새는 것을 발견하였다. 적절한 처치는?

V/S: 고열, 나머지는 정상범위

Lab: total protein, albumin, LFT(AST, ALT, GGT, total bilirubin) 모두 정상, CRP 상승

- 내시경온쓸개관스텐트삽입술
- 온쓸개관 T 자관 삽입술
- 온쓸개관 절제술
- 내시경 경화술
- 경과관찰

* 복경경 쓸개절제술로 발생할 수 있는 중증 합병증으로 담도 손상, 담도 누출, 출혈, 창자 손상이 있습니다. 쓸개주머니관을 묶은 부위에서 조영제 누출이 관찰된 것은 type A biliary injury (cystic duct remnant 또는 bile ducts of Luschka 에서 발생한 것)에 속하며, 거의 모든 type A 손상은 ERCP 시에 ampulla 를 통한 biliary stent 삽입으로 해결될 수 있습니다. 환자가 증상이 없고 간수치가 정상이며 추적 ERCP 검사에서 누출이 없다면 2 주 째에 스텐트를 제거할 수 있습니다.

28. 평소 음주량이 많던 환자. 위 내시경에서 다음과 같은 소견이 보였다. 예방하기 위한 처치는?



- ARB
- 베타블로커
- cefotaxime? cefoxitim?
- Calcium channel blocker
- glypressin

29. 61 세 남성. 배가 부풀어 올라 병원에 내원하였다. 10 년 전부터 하루 한 병 소주를 먹었으나, 배가 불러와 한 달 전부터 금주하였다. (lab 정상범위 주어짐)

V/S 정상

serum: Hb 저하, PLT 저하, LFT 에서 AST/ALT 정상, GGT 72, INR 증가, total protein 7.6, albumin-1.9, CRP 1.23

ascites: protein 1.6, albumin 0.6, glucose 117, LDH 61 가장 가능성 있는 진단은?

- 간경변
- 신증후군
- 복막결핵(tb peritonitis)
- 췌장염
- 복막암종(peritoneal carcinomatosis)

30.(Y) 27 세 남성 2 시간 전부터 발생한 혈변을 주소로 내원. 혈변 두 차례 하여 총 500mL 이고 혈압 76/42 -> 교정 후 100/80 됨. 다음으로 시행해야 할 검사는?

- 상부위장관내시경

- 대장내시경

<신장내과>

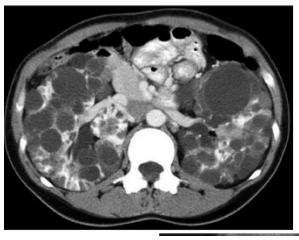
총 **10 문제** 중 **10 문제** 복원

야마 안탔습니다.

31. 40 세 여자가 혈뇨로 내원하였다. 다음 중 abdomen CT 를 찍어야 하는 경우는?

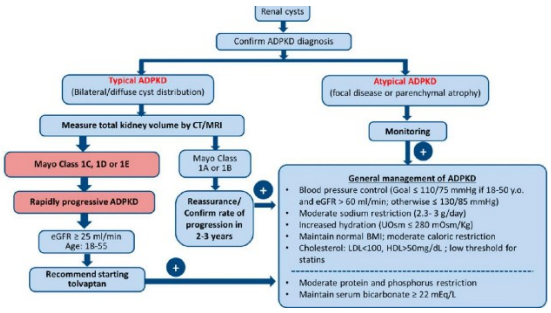
- 방광염 치료를 위해 항생제를 사용했었다
- 요 검사 결과 RBC 20-29/HPF 가 나왔다
- 과거 요로 결석 치료를 위해 여러 번 병원에 내원하였다

32. 45 세 남자가 복부팽만으로 내원하였다. 복부 CT 가 다음과 같을 때 알맞은 치료는?




- 2g/day 로 염분 섭취를 제한한다
- Severe protein restriction 해야 한다
- Mayo 1B 부터 tolvaptan 사용할 수 있다
- 근위세뇨관에 부담이 되므로 수분 섭취 제한해야 한다
- LDL <100, HDL>50 을 목표로 Statin 사용한다

*해설: PKD 염분 섭취는 2.3-3g/day 로 제한, Moderate protein restriction, Mayo class 1C 부터 tolvaptan 사용이 가능, UOsm 280 이하가 되도록 Hydration 늘려야 합니다.



33. (20 계통) 20 대 여성이 건강검진 이상소견으로 내원하였다. 활력징후는 100/70 - 60 회/분- 12 회/분 - 36.7°C 이었고, 혈액검사 결과 WBC/Hb/Plt 7000/13/240k, serum Na/K/Cl/HCO3- 140/2/100/28 으로 확인되었다. 최근에 구토나 이뇨제 복용력은 없었고, 출생시 특이 소견이 없었다고 한다. 소변 검사 결과 Urine Na/K/Cl 120/45/50, Urine Ca/Cr ratio 0.4 일 때, 다음 중 환자에게 유전적으로 문제가 있는 channel 은?

- Na+-Cl- cotransporter
- Na+-K+-2Cl- cotransporter
- N+-H+ exchanger
- ENac
- (anion 이라는 말이 들어가는 엄청 긴 영어 이름)

34. 20 대 여자가 다뇨로 내원하였다. 1 년 전 당뇨로 진단받고 약물 복용 중이며 최근에 다이어트한다고 물을 하루에 3L 씩 마셨다고 한다. 다뇨의 감별진단을 위한 검사로 가장 중요한 것은?

- 소변 오스몰 + 혈청 나트륨
- 수분제한검사
- ADH level
- 24h urine test
- Minirin 주고 소변양 검사

35. 42 세 여자가 빈뇨와 잔뇨감, 옆구리 통증을 주소로 내원하였다. 활력징후는 100/65 - 72 회/분- 12 회/분 - 38.7℃ 다. 혈액검사와 소변검사 결과가 아래와 같을 때 적절한 치료는? (Cipro 보기에 없었음)

WBC/Hb/Plt 18000/12.5/330k,
serum Na/K/Cl/HCO3-
140/4.5/105/26
BUN/Cr 23/1.2, AST/ALT 30/35,
Amylase/Lipase 30/15
RUA) Occult blood(-) RBC 0-
2/HPF, WBC many, Protein (-)

- 세프트리악손
- 암피실린
- 젠타마이신
- 반코마이신
- 카바페넴

36. 72 세 남자가 탈력감을 주소로 내원하였다. 어제까지 설사를 매일 10 번씩 하였고 체중은 3kg 감소하였다. 신체진찰에서 구강 점막이 말라있었다. 활력징후는 80/60mmHg - 100 회/분- 12 회/분 - 36.5℃ 다. 다음 중 가장 먼저 해야할 치료는? (인지기능 변화에 대한 정보는 없었음)

WBC/Hb/Plt 7000/11/230k,
serum Na/K/Cl/HCO3-
153/4.5/105/26
BUN/Cr 25/0.8, eGFR 75.6,
AST/ALT 24/18,
Amylase/Lipase 25/40
RUA) Occult blood(-) RBC 0-
2/HPF, WBC 0-2/HPF, Protein
(-)

- 0.9 N/S
- 승압제
- 지사제
- 응급투석? (0.45 N/S 는 보기에 없었음)

37. 72 세 남자가 의식 저하로 내원하였다. 대장암으로 진단받고 항암치료 중이며 내원 전날까지 일상생활 문제 없이 잘 지냈다. 신체진찰 결과 피부긴장도 정상이고 부종은 없었다. 활력징후는 90/60mmHg - 90 회/분- 12 회/분 - 36.7℃ 다. 혈액검사와 소변검사 결과가 아래와 같을 때 치료는?

WBC/Hb/Plt 7000/11/230k, serum
Na/K/Cl/HCO3- 108/2.0/98/24,
Ca/P 9.5/3.6
BUN/Cr 20/4.0, Serum Osm 298,
AST/ALT 35/22,
Amylase/Lipase 31/34
RUA) Occult blood(-) RBC 0-
2/HPF, WBC 0-2/HPF, Protein
(-)
Urine Na 130, Urine Osm 560

- 3% N/S
- 수분 제한
- 0.9% N/S
- 지사제
- 응급투석?

38. (19 학년말) 40 대 남자 환자가 10 년 전 IgA nephropathy 로 인한 ESRD 로 신장이식 후 면역억제제 복용 중이다. 1 달 전 Cr 1.2 이었고 이번에 재검사했더니 Cr 3.0 나왔다. 다음 중 옳은 것은?

- 초기 감별진단과 평가를 위해 소변검사와 신장 초음파가 중요하다
- IgA nephropathy 에 의한 급성 신부전이므로 혈중 면역억제제 농도는 잴 필요 없다.
- 크레아티닌의 상승은...(그냥 봐도 틀린 선지)
- 약물 복용력은 중요하지 않다.
- 응급상황이므로 즉시 입원하여 스테로이드 충격요법을 시행해야 한다.

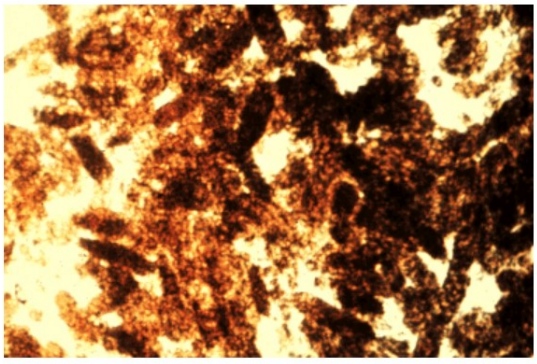
39. 다음 중 Acute tubular necrosis 를 시사하는 소변검사 결과는?(답논란)

- WBC Many/HPF
- 잠혈 +++
- 알부민 +++
- 요비중 1.020
- granular Cast, a few

* uptodate 에 따르면 granular cast 가 답일거라는 의견 있음.

© 2022 UpToDate, Inc. and/or its affiliates. All Rights Reserved.

Photomicrograph showing urine sediment with muddy brown granular casts



Urine sediment showing multiple muddy brown granular casts. These findings are highly suggestive of acute tubular necrosis in a patient with acute kidney injury.

40. 28 세 남자가 헬스를 하며 몸짱대회를 준비하던 중 콜라색 소변색과 양쪽 허벅지 통증이 생겨 내원하였다. 진단은?

WBC/Hb/Plt 7000/14.3/340k, serum Na/K/Cl/HCO3- 136/4.8/106/24, Ca/P 9.5/3.6
BUN/Cr 21/0.9, AST/ALT 35/22, Amylase/Lipase 31/34
RUA) Occult blood 3+, RBC 0-2/HPF, WBC 0-2/HPF, Protein trace

- 횡문근융해증
- 방광암
- 방광염
- 전립선비대증

<감염내과>

총 **5 문제** 중 **5 문제** 복원

감염 내과 실습 내용에서 주로 출제되었습니다. 실습 열심히 돌면 큰 어려움 없으리라 생각됩니다.

41. (Y) 코로나 19 감염 전파를 막기 위한 보호진의 착용구가 아닌 것?

- N95 마스크
- 방수 신발
- 1 회용 가운
- 고글
- 1 회용 장갑

42. (Y 변형) 발열을 주소로 온 환자에게 문진 할 것으로 옳지 않은 것은?

- 동물 노출력
- 직업
- 주변에 비슷한 증상이 있는 사람
- 여행력

- 이성 교제

43. 경험적 항생제 선택에 있어서 고려해야 할 것으로 옳지 않은 것은?

- 환자가 현재 복용 중인 약물
- 약물 알레르기력
- 해당 지역의 균 내성률
- 감염증별 통계적 감수성
- CRP 수치

44. (Y 변형) 다음 중 접촉 후 손을 씻어야 하는 경우는?

- 장티푸스
- 코로나 19
- VRE 접촉 후
- CRE 접촉 후
- C. difficile 접촉 후

45. 경구용 항생제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 주사용 항생제보다 항균력이 열등하다.
- 주사용 항생제보다 더 저렴하다.
- 정맥염이나 패혈증의 부작용 가능성이 더 낮다.
- 위장관 장애가 있을 때는 사용하지 않는 것이 좋다.
- 주사용 항생제보다 onset 이 느리다.

<혈액종양내과>

총 **5 문제** 중 **5 문제** 복원

46. (주관식) 급성 림프구성 백혈병에서 완전 관해의 정의를 쓰시오. 부분점수 없음.

1) no auer rods, no circulating blast

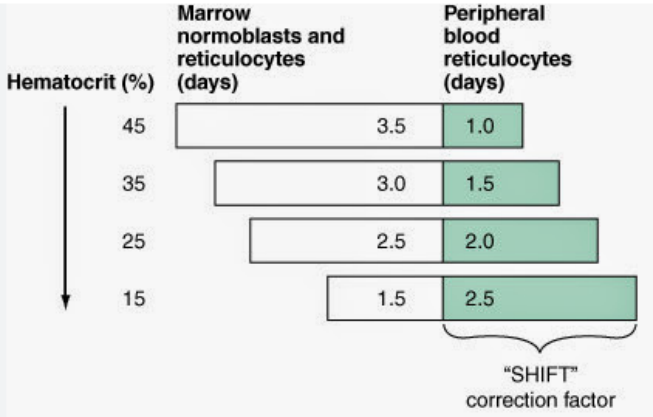
2) no extramedullary leukemia

3) ANC≥1000

4) platelet≥100000

5) blast<5%

47. (주관식) 사진을 참고하여 reticulocyte production index 를 계산하여라. Hct 22.5, Hb 7.5, reticulocyte 2%.



- 0.5

48. 39 세 여자가 1 주일 전부터 손, 발에 반점이 생겨 병원에 왔다. 가족력 없고 간질환이나 약물 복용력 없다. 발열이나 체중 감소 없다. 혈액검사결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 검사는? 백혈구 6400, 혈색소 12.4, 혈색소 11000, 망상적혈구 1.1%, 총빌리루빈 0.3, 혈청 크레아티닌 0.5

- 항글로불린검사
- 골수흡인생검
- 혈청 베타 2-저분자글로불린
- 말초혈액펴바른표본

49. 48 세 여자가 유방에 만져지는 종물로 내원하여 검사결과 유방암 2 기로 진단되었다. 가족력으로 이모가 난소암으로 치료받았다. 유방조직검사에서 에스트로젠 수용체 음성, 프로제스테론 수용체 음성, HER2 음성이었다. 다음으로 시행할 유전자 검사는?

- BRCA
- JAK2
- RAS
- BCR-ABL
- EGFR

50. 57 세 여성이 3 개월 동안 8kg 이 감소하여 내원했다. 발열 이외의 증상은 없었고 조직 검사 결과 diffuse large b-cell lymphoma 로 진단되었다. ECOG 2, 검사 결과 bone marrow cellularity 50%, Hb 감소, MCHC 증가, RDW 증가, LDH 452(140-271) 외 정상. 환자의 international prognostic index 는? (사진은 인터넷에서 가져옴)



A

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

<내분비내과>

총 **5 문제** 중 **5 문제** 복원

51. 55 세 남성, 우연히 발견된 pituitary macroadenoma 로 내원함. 병원에서 prolactinoma 로 진단받았으나 증상은 없음. 치료는?

- 경과관찰
- transsphenoidal surgery
- 브로모크립틴

52. 38 세 남성 좌측 갑상선 3.3cm nodule

T3 257 fT4 2.68 TSH 0.019 (정상치 주어짐)

3.3cm solid nodule

benign follicular nodule

치료는?

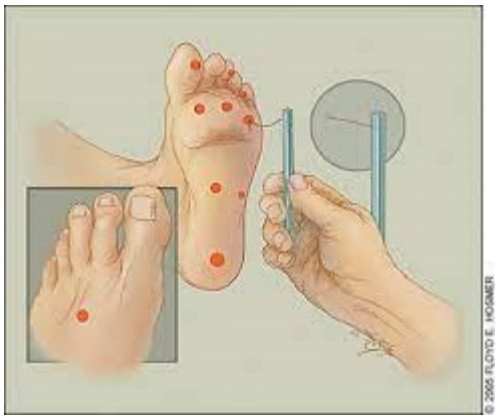
- PTU
- MTZ
- Radioiodine

53. Iatrogenic Cushing Syndrome 의 진단 방법은?

- Overnight dexamethasone suppression test
- 24hr cortisol test
- High dose dexamethasone suppression test

- Rapid ACTH stimulation test

54. 65 세 남성 흡연 40 갑년 (음주 30 년?)
발목동맥촉지정상 증상없음 감각있음



환자의 어떠한 기능을 평가하기 위한 검사인가?

- 압력
- 고유감각
- 통증
- 온도

55. 골다공증 65 세 여성

Region	Z score	T score
L1	2.6	2.9
L2	2.5	2.7
L3	2.4	2.5
L4	2.1	2.3
Femur neck	1.8	2.0
Femur total	2.3	2.5

진단은?

t score -2.6 osteoporosis

(이 외에 z/t score 로 선지 구성됨)

< 류마티스 내과 >

총 5 문제 중 5 문제 복원

56. 35 세 여성 환자가 관절통을 주소로 내원하였다. 6 년 전부터 양측 손목에 통증이 있어왔으며, 2 개월 전부터 양측 손목의 통증과 부종, 오른쪽 팔목의 부종, 오른쪽 2 번째 MCP 의 통증을 느끼기 시작하였다. 검사 결과 CBC Hb 12.6, WBC 9200, Platelet 17500, ESR 40 CRP 4, ANA (-)로 나타났을 때, 환자에게 가장 적절한 진단은?

- 통풍
- 류마티스 관절염
- 골관절염
- 강직성 척추염
- 반응성 관절염?

57. 22 세 남자 환자가, 10 년 전부터 구강궤양이 있어왔고, 얼굴 발진과 부종이 있어 내원하였다. 신기능 저하는 없었지만 proteinuria 1200/day 로 나타났다. 신장 biopsy 결과 class IV lupus nephropathy 로 진단받아 치료를 시작하였고 검사 결과 ANA 2560 dsDNA (+) SM (+), 보체 감소 소견이 나타나 고용량 스테로이드 및 mycophenolate fumel?로 치료를 시작하였다. 환자의 치료에 대한 반응 평가를 하기 위해 가장 적절한 수치는?

- ANA
- dsDna
- C3
- C4
- 단백뇨

58. (야마) 28 세 남자가 오른쪽 발목 아래의 관절통 때문에 내원하였다. 5 일 전부터 오른쪽 엄지 발가락이 붓고 압통 있었다.

외상은 없었다. 3 개월 전에도 오른쪽 엄지 발가락의 압통 있었으 나 5 일 내 호전되었다. 이 환자에서 진단을 위해 가장 필요한 검사는?

- 관절액천자
- CRP
- 류마티스인자 (Rhematoid factor)
- 요산 (uric acid)
- 항 CCP 항체 (ACPA)

59. 29 세 여자 환자가 오른쪽 2 번째 중수지 관절뷰터 양측 손목에 통증을 느껴 내원하였다. 6 개월전부터 통증이 느껴졌으며 아침에 일어날 때 가장 심하고, 통증은 최대 4 시간 정도까지 지속되었으며 이후 호전되었다. 검사 결과가 다음과 같을 때, 가장 적절한 진단방법으로 옳은 것은?

- RF positivity, UNL 3 배 이상
- Anti-CCP Ab positicity, UNL 3 배 이상
- CRP 상승여부
- 다른 염증성자가면역질환 증상 확인...

- 섬유근육통 (Fibromyalgia)

60. 24 세 남자 환자가 허리 통증을 주소로 내원하였다. 눈 침범 x, 양측 천장관절염. 진단에 있어 가장 필요한 검사? (Ankylosing spondylitis)

- 허리 운동범위 검사
- B27
- 요추 영상검사